

Perte de connaissance en équipe

Lorsque la victime a perdu connaissance et respire, lors d'une intervention en équipe, il convient pour cette dernière d'appliquer la conduite à tenir suivante :

A la suite d'un évènement non traumatique

- la placer en position stable sur le côté, en position latérale de sécurité (PLS¹) à un secouriste ;

A la suite d'un traumatisme ou d'un événement d'origine inconnue

- dans l'attente d'un avis médical :
 - laisser la victime sur le dos dans l'attente d'un avis médical ;
 - poursuivre la stabilisation de la tête de la victime à deux mains ;
 - assurer une liberté des voies aériennes permanente ;
- poursuivre l'évaluation des fonctions vitales ;
- demander un avis médical et appliquer leurs consignes ;
 - installer la victime en PLS à deux secouristes² **seulement sur indication médicale** ;
 - sinon la laisser sur le dos.

Dans tous les cas

- si nécessaire :
 - administrer de l'oxygène en inhalation ;
 - réaliser une aspiration³ des sécrétions ;
- protéger la victime contre le froid, la chaleur ou les intempéries.
- poursuivre le bilan et surveiller attentivement :
 - la conscience de la victime ;
 - la respiration.

¹ Le retournement sur le côté gauche de la femme enceinte, ou d'une victime obèse, permet d'éviter l'apparition d'une détresse par compression de certains vaisseaux sanguins de l'abdomen.

² Une palpation sommaire à la recherche de lésions traumatiques permet de définir au préalable le côté de retournement lors de la PLS.

³ Si la victime présente des signes d'encombrement des voies aériennes supérieures, afin d'améliorer la respiration.